

LA TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE

Faculté de médecine de Constantine

Pr. Mokrane Zine Labidine

Pr. Mokrane Zine Labidine

LA TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE

PLAN DU COURS

I.Généralités :

II.Etio-pathogénie ou Transmission

III.Clinique

IV.Imagerie Thoracique

V.Biologie et immuno diagnostic

VI.Bactériologie

VII.Diagnostic positif

VIII. Diagnostic différentiel

IX. Traitement

Références bibliographiques

INTRODUCTION

- La tuberculose reste un problème de santé publique, aussi bien à l'échelle mondiale que nationale
- Le programme nationale de la lutte anti-tuberculeuse a permis de réduire le taux de TBC surtout dans sa forme contagieuse:
- Passant de plus de 70 cas/ 100 000 habitants en 1975 à 16.9 cas en 2015 (40 ans plus tard)
- Néanmoins, cette recrudescence s'est accompagnée d'une augmentation des autres formes: les TEP qui occupaient moins de 18% des TBC, en 2015 elles constituaient 64.9%.

I. Définition de la tuberculose pulmonaire:

C'est l'infection du parenchyme pulmonaire par le bacille de Koch **réalisant** le plus souvent une atteinte infiltrative et/ou ulcérée.

Caractérisée essentiellement par des signes cliniques durables plus de 15 jrs, de signes radiologiques et biologiques.

II. Transmission :

- Elle est **exclusivement interhumaine**
- Se propage quasi exclusivement par voie aérienne
- Un malade porteur de lésions bacillifères est fortement contagieux,(
gouttelettes de salive (de Pflüge).
- En moyenne **5 – 10 %** des personnes infectées voient leur **infection devenir maladie** tuberculeuse dans les **3 – 5 ans** après la PIT.

Elle est due :

- Soit à une **réinfection endogène**, à distance d'une primo-infection non traitée (cas le plus fréquent).
- Soit à **une réinfestation exogène** massive (plus rarement).

III. Les groupes à haut risques :

On distingue:

A. les groupes à hauts risques **traditionnels**:

- 1 - socio-économiques défavorisés.
- 2 - diabète, d'ulcère, ou ayant subi une gastrectomie.
- 3 - anciens tuberculeux de l'ère **pré antibiothérapique** n'ayant pas reçu de chimiothérapie spécifique?.
- 4 - long séjour en milieu psychiatrique.
- 5 - personnels soignants très exposés au cours de leurs activités professionnelles au sein d'établissements contaminés.

B. les groupes à hauts risques **actuels:**

- 1 - les **exclus sociaux** (fréquence de l'intoxication tabagique, alcoolique).
- 2 - les sujets séropositifs pour le **VIH**.
- 3 - les **immunodépressions** diverses: néoplasie, hémopathie, traitements à base de cortisone, Immunodépresseurs, transplantations d'organes.
- 4 - les sujets **dialysés** chroniques.
- 5 - les **toxicomanes**.
- 6 - les **détenus**

IV. Diagnostic positif :

Repose sur des arguments anamnestiques, cliniques,
radiologiques et biologiques.

La **certitude** est apportée par l'examen **bactériologique**.

1- la clinique :

a- Circonstance de découverte

Il **n'existe pas de signe pathognomonique** de la tuberculose cependant il existe plusieurs modes de début clinique de la TPC :

- Début insidieux :

Fébricule vespéral $37.5^{\circ} - 38^{\circ}$, Asthénie , Amaigrissement

, Anorexie

Sueurs nocturnes

Toux discrète sèche ou productive , Expectoration aigue majeure : elle peut être banale, muqueuse, ou franchement purulente fréquemment déglutie, elle manque chez la femme et l'enfant.

Trouble menstruels (aménorrhée) et digestifs (anorexie) sont inconstant

Révélation par **hémoptysie** : elle peut révéler une TP méconnue dans **10 %** des cas .

Dyspnée et douleur thoracique plus rarement révélateur **15 – 20 %**

- **Début bruyant** :

T° à 39° avec frisson.

Toux, expectoration, AEG.

Ce tableau évoque le dg d'une pneumopathie bactérienne ou virale.

- Latence clinique complète :

Lors d'un contrôle **radiologique systématique** :

Contrôle professionnel, contrôle de l'entourage d'un sujet
contaminateur, contrôle d'une sujet à risque (immunodéprimé)

b- interrogatoire : devra rechercher :

- **contage** tuberculeux (familiale voisinage ou entourage professionnel)
- **profession** exposante chez le malade (étudiant, infirmier de service de phtisiologies).
- **antécédents** tuberculeux chez le malade.
- **coexistence** d'affections.
- Vaccination du **BCG**

L'examen physique :

généralement **pauvre** car il faut en arriver à des dégâts
parenchymateux majeurs

pour retrouver une symptomatologie de condensation ou
une symptomatologie cavitaire.

2- La radiologie :

Il existe 4 types d'images : **isolée ou associée**

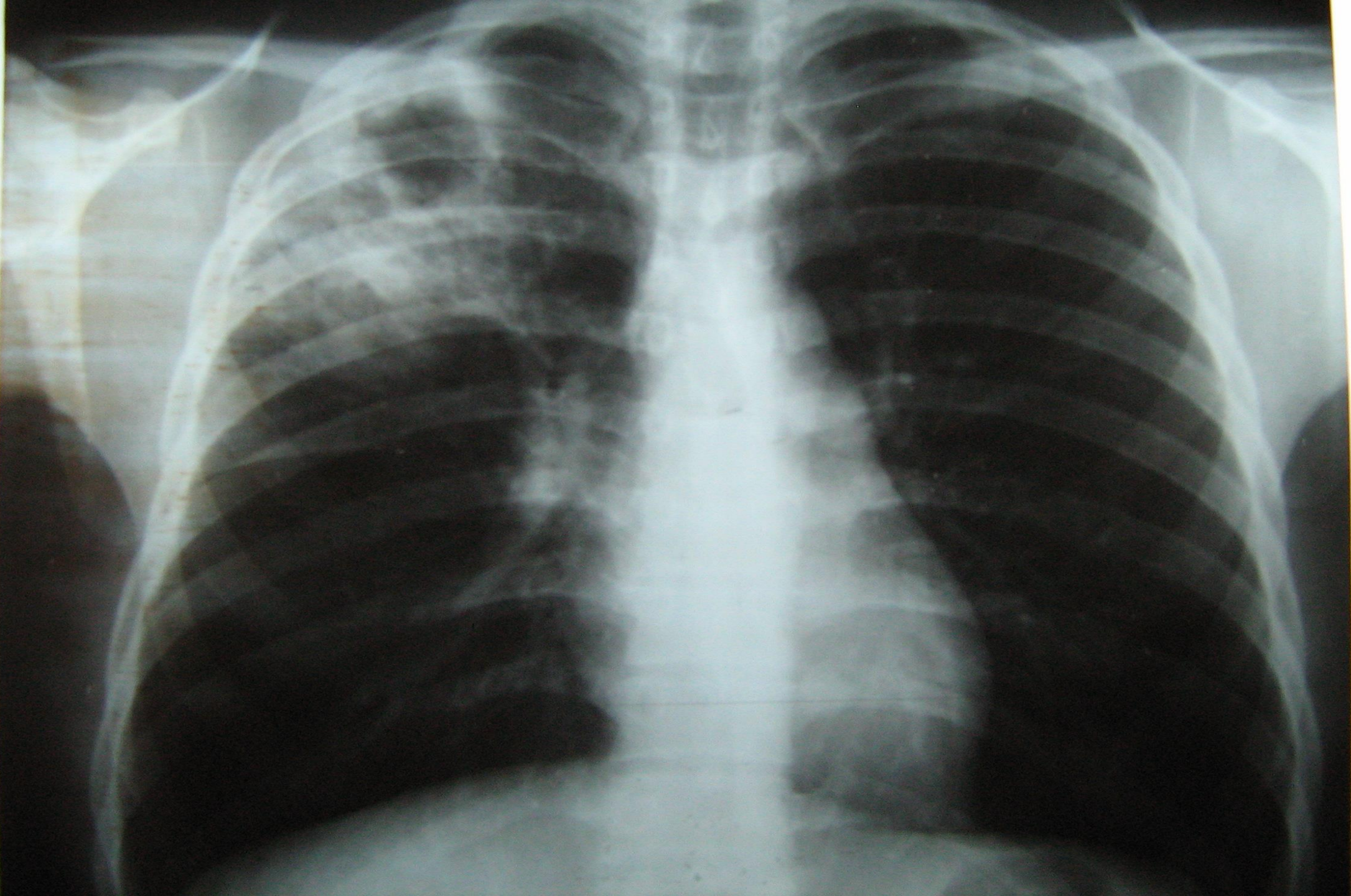
Les images **nodulaires** :

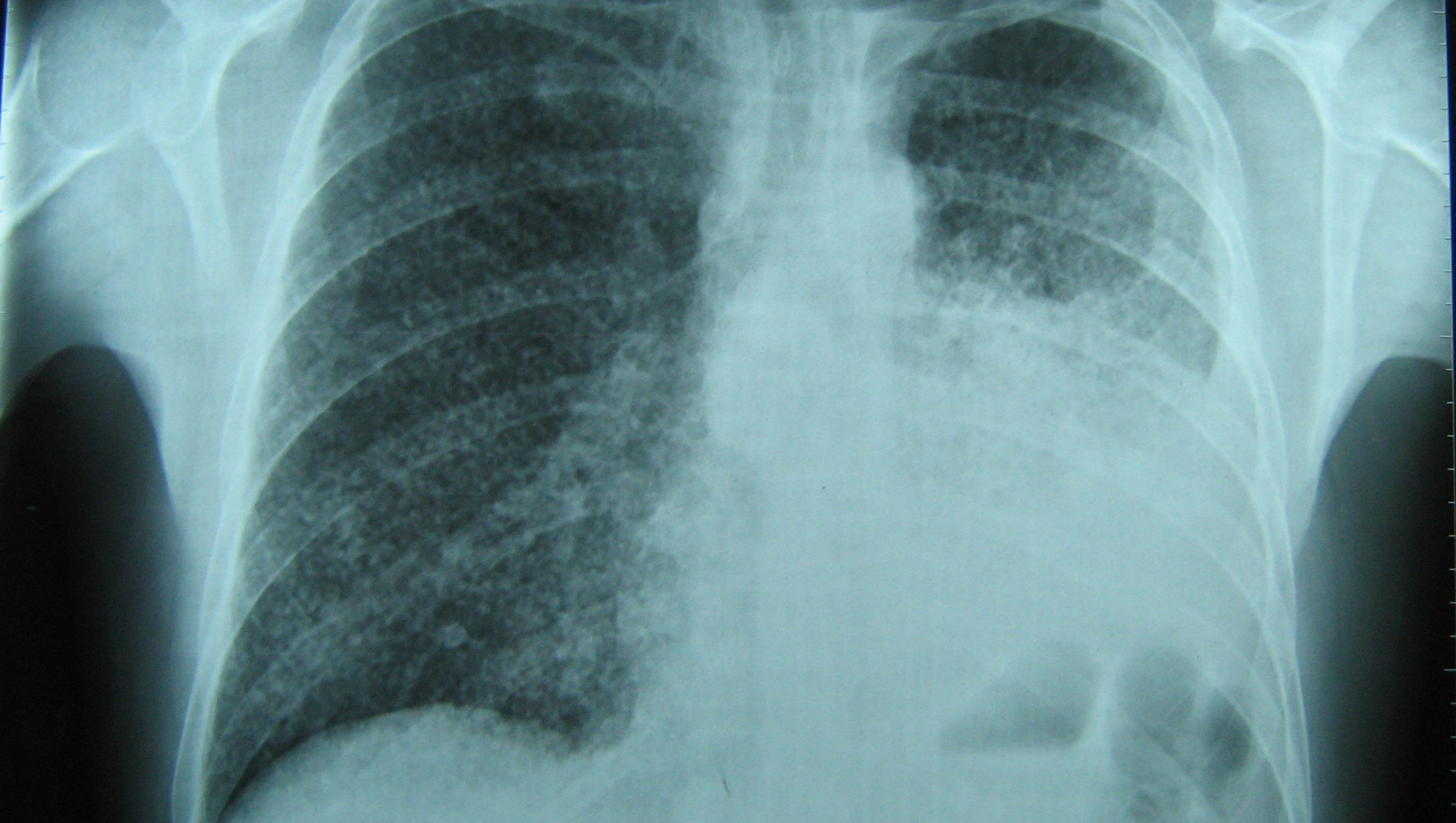
Les **infiltrats**

- **Opacités linéaires** :

- La **caverne tuberculeuse** :

C'est l'image la plus évocatrice de la TPC





Elles peuvent être **associées** à des lésions d'âge différent,
plus anciennes:

- images “fibreuses”, rétractions étoilées
- nodules plus ou moins calcifiés
- épaissements pleuraux localisés

Ces lésions peuvent être **bilatérales** et extensives.

3- La biologie :

VS : accélérée

FNS : leuco-neutropénie avec lymphocytose
voire **TDI G**

4- L'intradermoréaction à la tuberculine (IDR):

le plus souvent >10 mm

5- Les éléments de certitudes : réalisé par les examens
bactériologiques :

A - la recherche de **BK dans l'expectoration** : seul cet examen permettra d'affirmer le diagnostic

méthode de recueil : 3 Situations

a. chez les patients cracheurs : expectoration matinale à jeun 3j de suite répéter l'examen si nécessaire

b. chez les patients non cracheurs ou (femmes et enfants) tubage matinal à jeun 3jours de suite (parfois plus)

c. chez les patients porteurs de lésions minimales non excavées : pratiquer un fibro aspiration in situ : l'expectoration des **24h** qui suivent **la fibroscopie** sera prélevée car elle est souvent (+)

La recherche de BK se fait par :

1- **examen directe** des crachats : présence de bacilles acido-alcool résistants (BAAR). Il faut répéter les prélèvements avant la mise en route du traitement dans **80 %** des cas

2- **culture** : **20 % des cas**, après décontamination des crachats par soude 4 %

- culture traditionnelle sur milieu de Lowenstein-Jensen : résultat obtenu au 28, **42**, 72ème jour

- Culture sur milieu solide BACTEC:

3- **antibiogramme** : sera demandé :

- La notion d'une contamination par un malade résistant.
- En cas de BK (+) aux examens de contrôle au 5 – 6ème mois de traitement.

B. Recherche de BK dans les autres sites de prélèvements

VII. Diagnostic différentiel

A - Clinique:

- Pneumopathie bactérienne,
- Pneumopathie virale

B - Radiologique :

- Opacité ronde : KHP , Abscès en phase de collection , Angiome, TB , TM primitive ou secondaires,.
- Caverne : KHP rompu, lésion Bulleuse, Aspergilome, Abscès détergé

VIII. Traitement

- Tuberculose commune jamais traitée
- Tuberculose commune déjà traitée : une fois , deux fois

IX.Prévention

X. Références Bibliographiques